

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE METACOGNICIONES (MCQ-30)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de Creencias Metacognitivas y Síndrome Cognitivo Atencional (CAS)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Metacogniciones - 30 (MCQ-30).
Nombre Original (Inglés)	<i>Metacognitions Questionnaire 30 (MCQ-30)</i>
Autores Originales	Drs. Adrian Wells y Samantha Cartwright-Hatton (2004), University of Manchester.
Adaptación Española	Juan Ramos-Cejudo, José M. Salguero y Antonio Cano-Vindel (2013), Universidad Complutense de Madrid.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo S-REF y Terapia Metacognitiva (MCT) de Wells.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 30 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adolescentes (≥ 13 años) y adultos. Aplicable en clínica especializada y comunitaria.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos en autoadministración; 10 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento académico abierto para uso clínico y de investigación científica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO S-REF DE ADRIAN WELLS

El MCQ-30 operacionaliza el modelo de la Función Ejecutiva Autorreguladora (S-REF) formulado por Adrian Wells y Gerald Matthews. La premisa nuclear de la Terapia Metacognitiva (MCT) sostiene que el sufrimiento psicológico crónico no está causado primariamente por el contenido de los pensamientos negativos ("lo que la persona piensa"), sino por cómo la persona responde a esos pensamientos y las creencias que mantiene sobre su propio funcionamiento mental: las **metacogniciones**.

Cuando las creencias metacognitivas desadaptativas se activan, disparan el **Síndrome Cognitivo Atencional (CAS)**, caracterizado por preocupación incontrolable, rumiación perseverativa, hipervigilancia a señales de amenaza y conductas de control mental contraproducentes. Neurobiológicamente, el MCQ-30 captura fallos en las redes frontopolares y dorsolaterales de monitorización de segundo orden (corteza prefrontal anterior área 10 de Brodmann y córtex cingulado anterior), donde la mente se queda atrapada en bucles autorreferenciales sin capacidad de término ejecutivo voluntario.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Factor Metacognitivo	Ítems (6 c/u)	Rango	Operacionalización Clínica y Fenomenológica
1. Creencias Positivas (POS)	1, 7, 10, 19, 23, 28	6 a 24	Creencia de que preocuparse es una herramienta útil para resolver problemas, prevenir catástrofes o afrontar el futuro.
2. Incontrolabilidad / Peligro (NEG)	2, 4, 9, 11, 15, 21	6 a 24	Creencias de que los propios pensamientos pueden volverse incontrolables, hacerle perder la razón o causar colapso físico.
3. Confianza Cognitiva (CC)	8, 14, 17, 24, 26, 29	6 a 24	Falta de fe o desconfianza subjetiva en la propia memoria, concentración y retención de información mental.
4. Necesidad de Control (NC)	6, 13, 20, 22, 25, 27	6 a 24	Creencia imperativa de que se deben castigar o suprimir los pensamientos perturbadores para evitar ser culpable.
5. Autoconciencia Cognitiva (CSC)	3, 5, 12, 16, 18, 30	6 a 24	Tendencia a monitorizar e inspeccionar continuamente los propios procesos de pensamiento de forma obsesiva.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión: alfa de Cronbach total de 0.91 en validación española (Ramos-Cejudo et al., 2013). Factores específicos: NEG (0.87), CC (0.85), POS (0.84), NC (0.76) y CSC (0.75).
Estructura Pentafactorial	El AFC valida el modelo de 5 factores intercorrelacionados (CFI = 0.94, RMSEA = 0.052), demostrando total equivalencia estructural con el modelo británico original de Wells y Cartwright-Hatton.
Validez Concurrente y Predictiva	El factor NEG (Incontrolabilidad/Peligro) es el predictor más potente de la varianza en preocupación patológica (PSWQ, $r = 0.68$), ansiedad clínica (GAD-7, $r = 0.65$) y obsesiones (OCI-R, $r = 0.58$).
Sensibilidad al Cambio	Herramienta de monitorización estándar en Terapia Metacognitiva (MCT), exhibiendo reducciones clínicamente significativas de gran tamaño de efecto (d de Cohen > 0.90) postratamiento.
Invarianza de Medida	Invarianza métrica demostrada entre poblaciones clínicas y no clínicas en diversos contextos hispanos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 30 ítems se responde en una escala de 4 puntos: **1** = «No estoy de acuerdo», **2** = «Ligeramente de acuerdo», **3** = «Moderadamente de acuerdo», **4** = «Totalmente de acuerdo».

- **Cálculo de los 5 Factores:** Se suman los 6 ítems que corresponden a cada subescala (Rango por factor: **6 a 24 puntos**).
- **Puntuación Total MCQ-30:** Suma aritmética de los 30 reactivos (Rango total: **30 a 120 puntos**). No contiene reactivos invertidos.
- **Jerarquía Diagnóstica:** Aunque la puntuación global refleja la intensidad del CAS, el factor **NEG (Incontrolabilidad y Peligro)** es el indicador patológico central que determina el pronóstico terapéutico.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Nivel CAS	Rango Total	Perfil Metacognitivo	Significación Clínica y Terapéutica
Bajo / Funcional	30 a 50	Flexibilidad metacognitiva adaptativa	Pensamientos vistos como meros eventos mentales pasajeros. Ausencia de rumiación obsesiva o parálisis.
Moderado	51 a 69	Activación del CAS intermitente	Tendencia a darle excesiva importancia a la preocupación y esfuerzo moderado por controlar la mente.
Elevado	70 a 89	Disfunción metacognitiva clínica (≥ 70)	El sujeto cree que sus pensamientos son incontrolables o peligrosos. Indicación de Terapia Metacognitiva.
Severo	90 a 120	Colapso metacognitivo generalizado	CAS perpetuo e invalidante. Máximo riesgo de cronificación en TAG, depresión mayor o agorafobia.

CRITERIO CRÍTICO: FACTOR NEG (INCONTROLABILIDAD Y PELIGRO):

Una puntuación en la subescala **NEG ≥ 15 puntos** (percentil 80) es el marcador clinimétrico de viraje hacia la psicopatología. Cuando el paciente cree que «su mente va a estallar» o que «no puede parar de preocuparse», la terapia cognitivo-conductual ordinaria fracasa si discute contenidos en lugar de desmontar la falsa creencia de incontrolabilidad.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN TERAPIA METACOGNITIVA (MCT)

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DESESTRUCTURADOR DEL CAS:

- **Paso 1: Desmantelar Metacreencias Negativas (NEG $\geq$ 15):** Prioridad absoluta. Experimentos conductuales de pérdida de control programada y postergación de la preocupación (demostrar que la preocupación es una estrategia voluntaria y no un proceso incontrolable).
- **Paso 2: Entrenamiento en Atención (ATT):** Desactivar el monitor cognitivo (CSC) mediante ejercicios auditivos de reorientación voluntaria de la atención para romper la hipervigilancia interna.
- **Paso 3: Desafío a Metacreencias Positivas (POS $\geq$ 14):** Desmontar la utilidad percibida de la preocupación ("¿Preocuparse toda la noche impidió que ocurriera el problema o solo le quitó el sueño?").
- **Paso 4: Modo Mindfulness Desapegado (Detached Mindfulness):** Aprender a observar los pensamientos sin responderles.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Paciente: Varón de 36 años, economista de empresa, con historia de 4 años de ansiedad generalizada refractaria a ISRS y a terapia cognitiva clásica. Consulta afirmando: «Sé que mis pensamientos no son racionales, pero si intento frenarlos me vuelvo loco».

Evaluación Inicial MCQ-30: Total = **86 puntos** (Disfunción metacognitiva severa; percentil 92).

- **Subescala NEG (Incontrolabilidad): 22 / 24 puntos** (ítems 2, 4, 9, 15 = 4: terror a perder el control mental).
- **Subescala POS (Creencias Positivas): 19 / 24 puntos** (cree firmemente que si deja de preocuparse cometerá errores garrafales).
- **Subescala CSC (Autoconciencia): 20 / 24 puntos** (escaneo atencional ininterrumpido de su estado mental).

Formulación Metacognitiva: El paciente sufría una meta-preocupación catastrófica ("preocuparse por preocuparse"). La reestructuración de contenidos previos reforzó su CAS al obligarlo a pensar más sobre sus pensamientos.

Intervención y Evolución: Se aplicó protocolo MCT de Wells de 10 sesiones: ATT y experimentos de postergación de la preocupación a una ventana de 15 minutos por la tarde. Al mes 3, el MCQ-30 descendió a **44 puntos** (NEG cayó de 22 a 8), con remisión completa del TAG y supresión de ansiolíticos.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DIFERENCIAL

RIESGO IATROGÉNICO DE LA REESTRUCTURACIÓN CLÁSICA

En pacientes con alta Autoconciencia Cognitiva (CSC $\geq$ 18) y Necesidad de Control (NC $\geq$ 16), pedirles que "debatan racionalmente sus pensamientos automáticos" suele alimentar el CAS y exacerbar la rumiación obsesiva.

BAJA CONFIANZA COGNITIVA EN TOC Y ANCIANOS

Puntuaciones extremas en CC (Confianza Cognitiva $\leq$ 10 invertido / puntaje bruto alto) predicen compulsiones de verificación en TOC y pseudodeterioro atencional en personas mayores con ansiedad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. *Behaviour Research and Therapy*, 42(4), 385–396.
2. Ramos-Cejudo, J., Salguero, J. M., & Cano-Vindel, A. (2013). Spanish version of the Meta-Cognitions Questionnaire 30 (MCQ-30). *The Spanish Journal of Psychology*, 16, e95.
3. Wells, A. (2009). *Metacognitive therapy for anxiety and depression*. Guilford Press.
4. Sun, X., Zhu, C., & So, S. H. (2017). Dysfunctional metacognition across psychopathologies: A meta-analytic review. *European Psychiatry*, 45, 139–153.